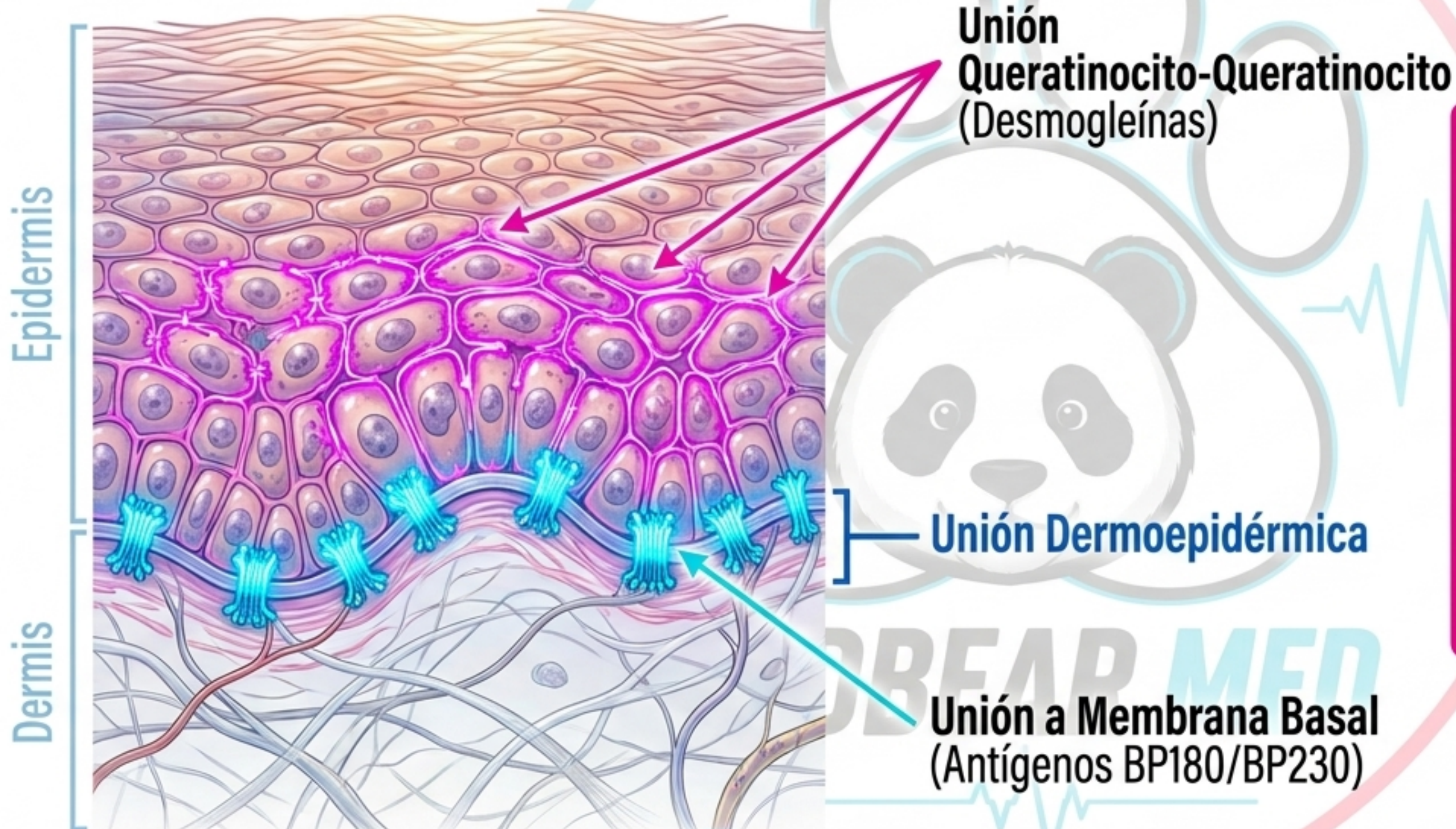




ENFERMEDADES AMPOLLARES AUTOINMUNES

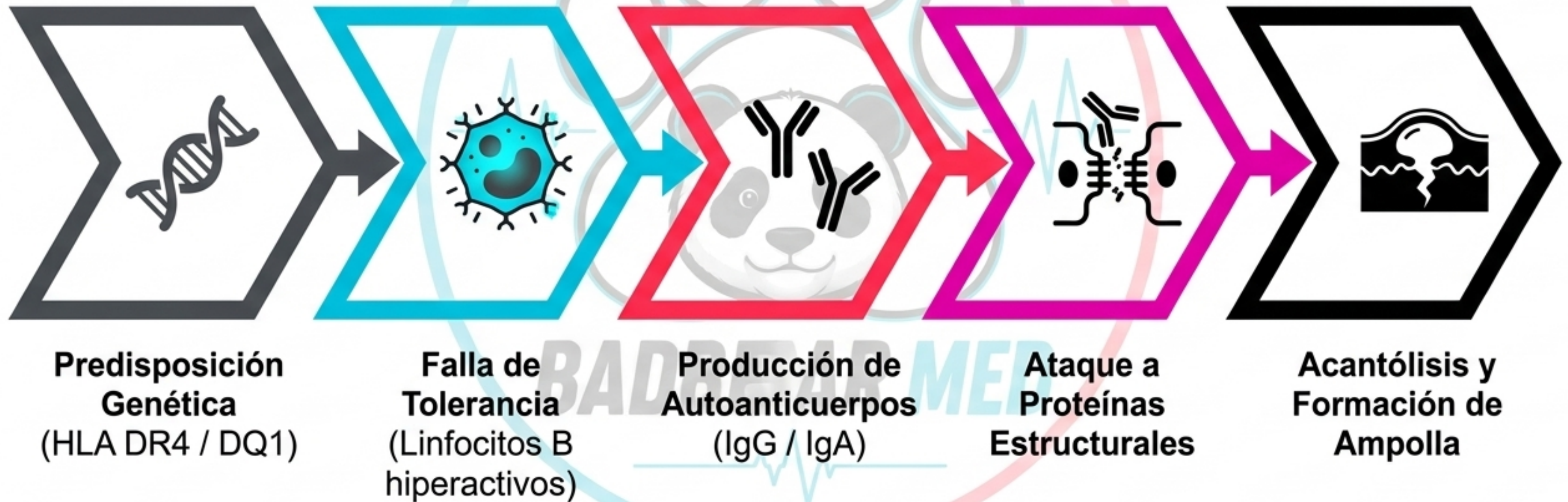
Guía de Estudio Clínico, Histopatológico
y Terapéutico de Alto Rendimiento

Anatomía Molecular de la Piel: El Sistema de Anclaje



La clave diagnóstica es el nivel de clivaje: ¿Dónde ocurre la ruptura?

Fisiopatología del Ataque Autoinmune



La Matriz de Clivaje: Taxonomía General

GRUPO INTRAEPIDÉRMICO (Pénfigos)

- **Nivel:** Epidermis (Acantólisis)
- **Dianas:** Desmogleínas (1 y 3)
- **Clínica:** Ampollas flácidas, erosiones, costras. Piel desnuda.
- **Signo de Nikolsky:** POSITIVO (+)

GRUPO SUBEPIDÉRMICO (Penfigoides)

- **Nivel:** Unión Dermoepidérmica
- **Dianas:** Antígenos BP (180 y 230) en hemidesmosomas
- **Clínica:** Ampollas grandes y tensas, líquido seroso claro.
- **Signo de Nikolsky:** NEGATIVO (-)

Pénfigo Vulgar: El Prototipo Grave

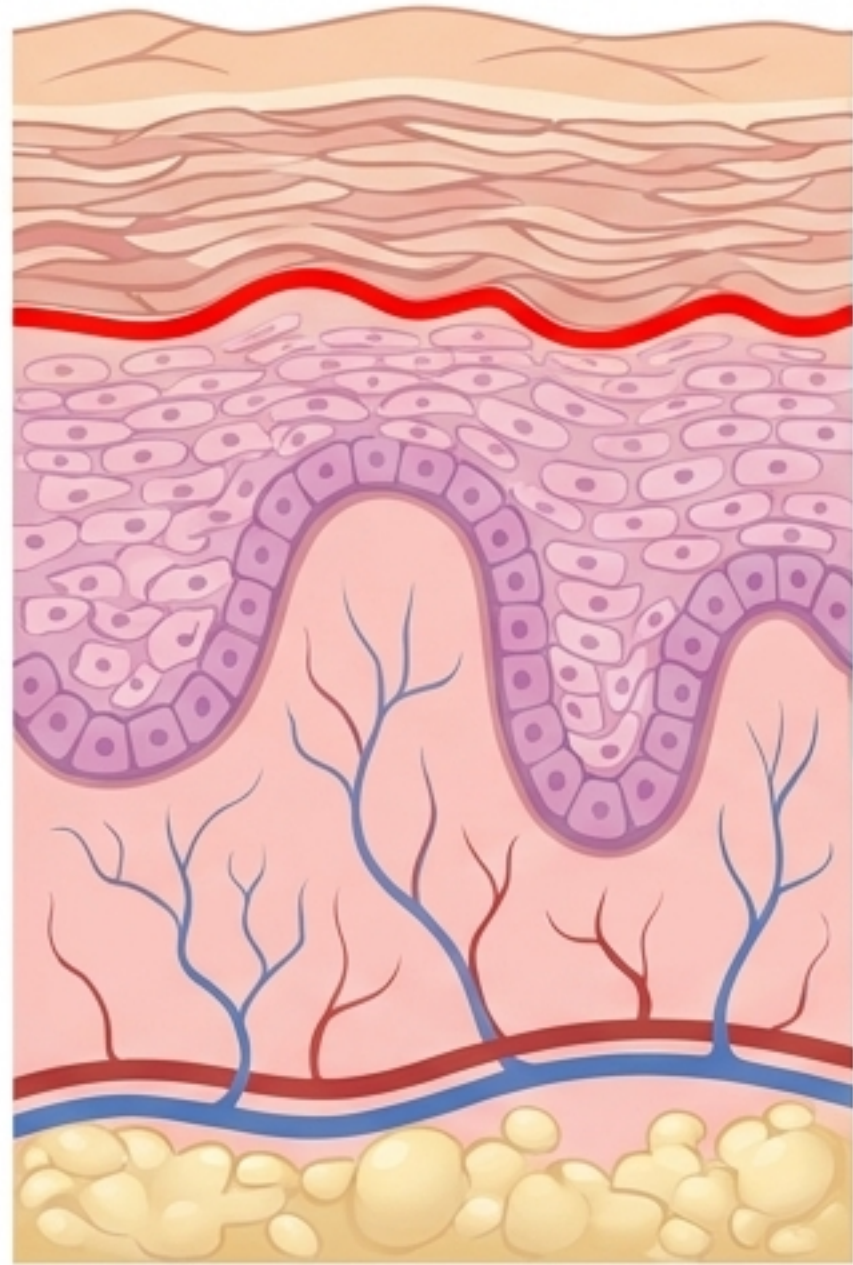
Ficha Técnica

- **Edad:** 5ta década de la vida.
- **Diana Molecular:** Desmogleína 3 (mucosas) y 1 (piel).
- **Inicio Clínico:** Compromiso severo en **CAVIDAD ORAL** precoz (dolor agudo, disfagia).
- **Progresión:** Erosiones extensas en piel (**aspecto de gran quemado**).

Riesgo vital por pérdida de proteínas, líquidos y alteración de la termorregulación.



Pénfigo Foliáceo y Variantes



Clivaje extremadamente superficial (Subcórneo)

Foliáceo Clásico

Ataque exclusivo a Desmogleína 1.
Cero afectación de mucosas.
Presenta escamas y costras con apariencia de hojas caídas.

Pénfigo Seborreico (Seniar-Usher)

Localizado en áreas ricas en glándulas sebáceas (región centrofacial, preesternal, interescapular).
Es la variante más frecuente.

Pénfigo Endémico (Fogo Selvagem)

Brotes geográficos específicos (ej. fronteras amazónicas, Paraguay). Fuerte hipótesis de transmisión por picadura de la mosca *Simulium nigrimanum*.

Penfigoide Ampollar

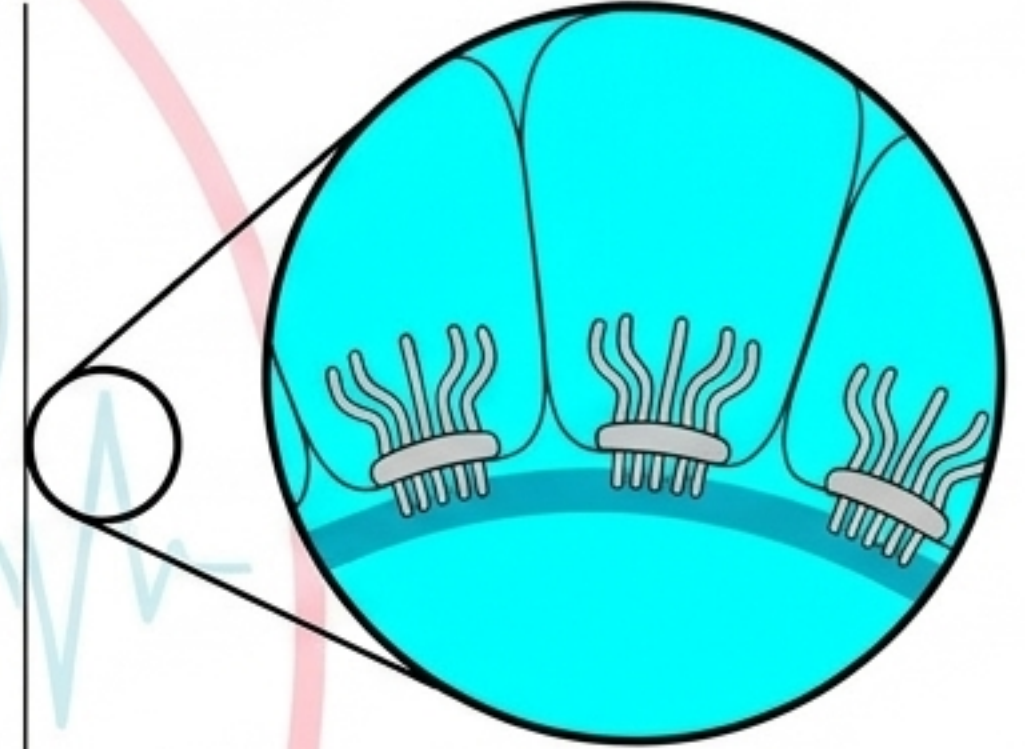
Perfil del Paciente:

Generalmente de la 6ta a 7ma década de la vida.

Requiere manejo cuidadoso por comorbilidades geriátricas asociadas.



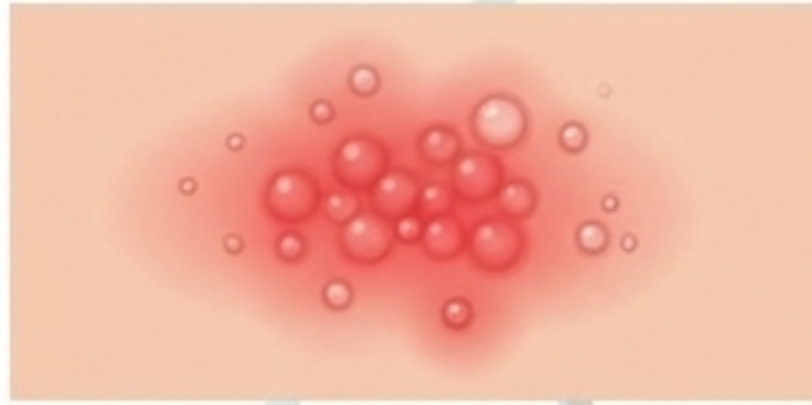
Ampollas TENSAS que no se rompen fácilmente.



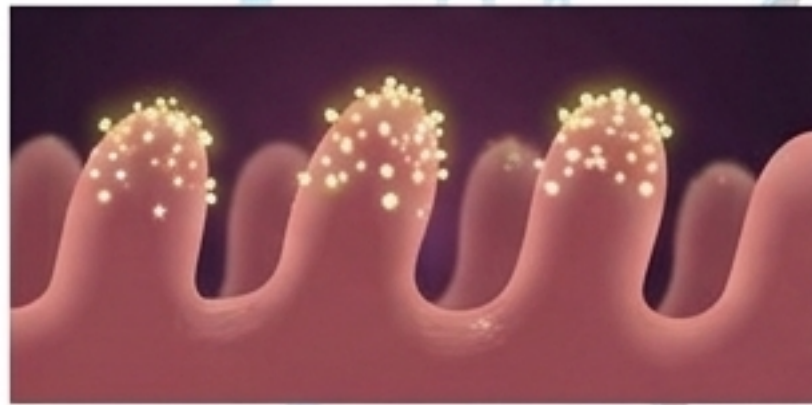
Diana Molecular:
Antígenos BP180 y BP230 en hemidesmosomas.

Manejo Clínico: Ruptura controlada de ampollas + Solución astringente (Burow) + Terapia sistémica adaptada.

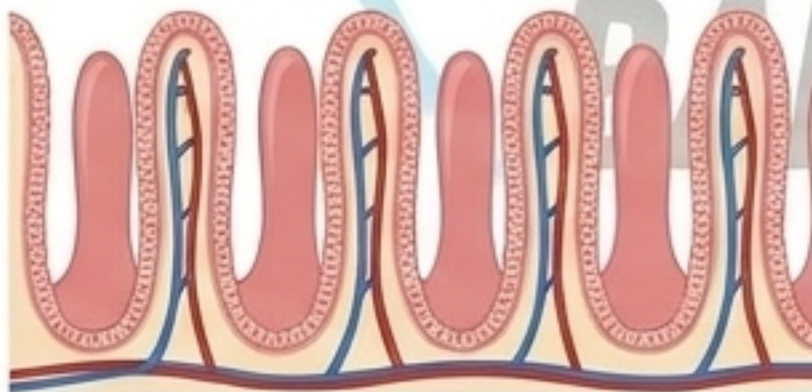
Dermatitis Herpetiforme (Enfermedad de Duhring-Brocq)



Piel: Vesículas y pápulas herpetiformes, extremadamente pruriginosas.



Inmunidad: Depósitos granulares de IgA en papilas dérmicas. Reacción cruzada contra Transglutaminasa Tisular (TG2).



Intestino: Vínculo ineludible con la Enfermedad Celíaca. Sensibilidad al gluten, HLA DQ2/DQ8 y malabsorción vitamínica.

Genodermatosis: El Factor Hereditario

Enfermedad de Hailey-Hailey (Pénfigo familiar crónico benigno)



- Afecta GRANDES PLIEGUES (cuello, axilas, ingles).
- Defecto genético persistente, no autoinmune.
- Tratamiento crónico sintomático.

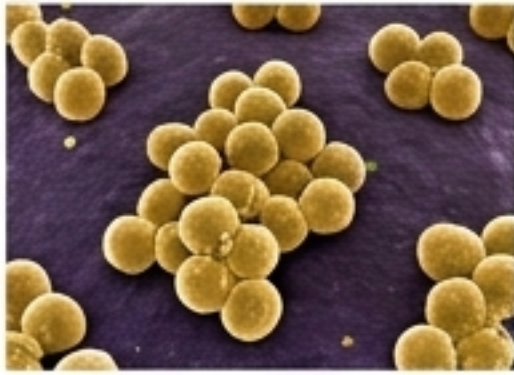
Epidermólisis Ampollar (Niños Mariposa)



- Mutaciones en genes de proteínas estructurales.
- Fragilidad extrema de piel y mucosas ante mínima fricción.
- Presente desde el nacimiento. Sin cura, manejo estricto de soporte.

Emergencia Pediátrica: Síndrome Estafilocócico de la Piel Escaldada (Ritter)

El Agente:



Estafilococo
coagulasa positivo.

El Arma:



Exotoxinas
exfoliativas A y B.

La Diana:



Destrucción de
Desmogleína 1
(Imita al pénfigo foliáceo
con clivaje subcórneo).

Emergencia absoluta: Requiere ingreso inmediato a UCI Neonatal.



Toxicodermias Severas: Espectro SSJ y NET

Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) | <10% Superficie Corporal

Síndrome de Superposición (Overlap) | 10% - 30% SC

Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) | >30% SC (Mortalidad ~40%)

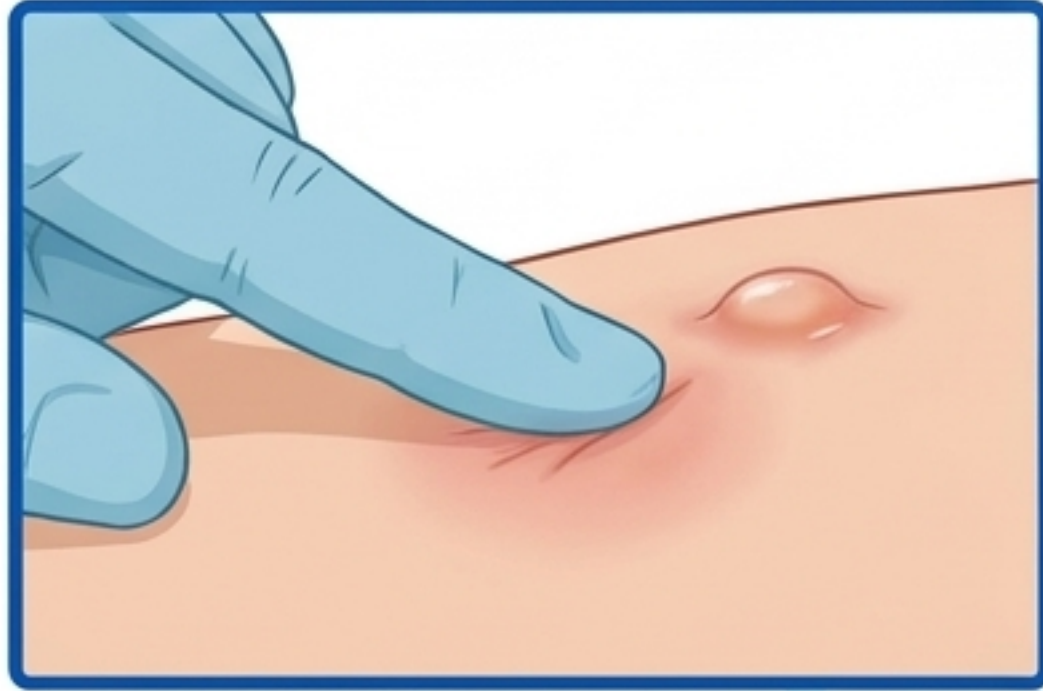
Principales Desencadenantes:

- Anticonvulsivantes
- Antimicrobianos
- Alopurinol
- AINEs

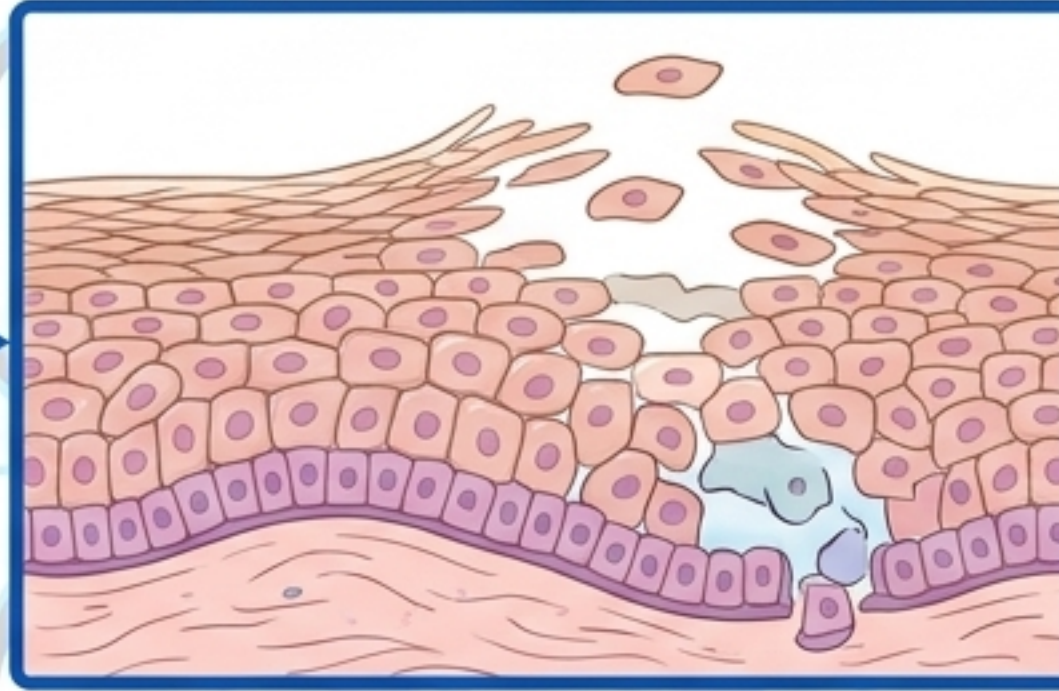


Mecanismo: Células NK / CD8 inducen apoptosis masiva de queratinocitos vía FasL, Perforina y Granzima B.

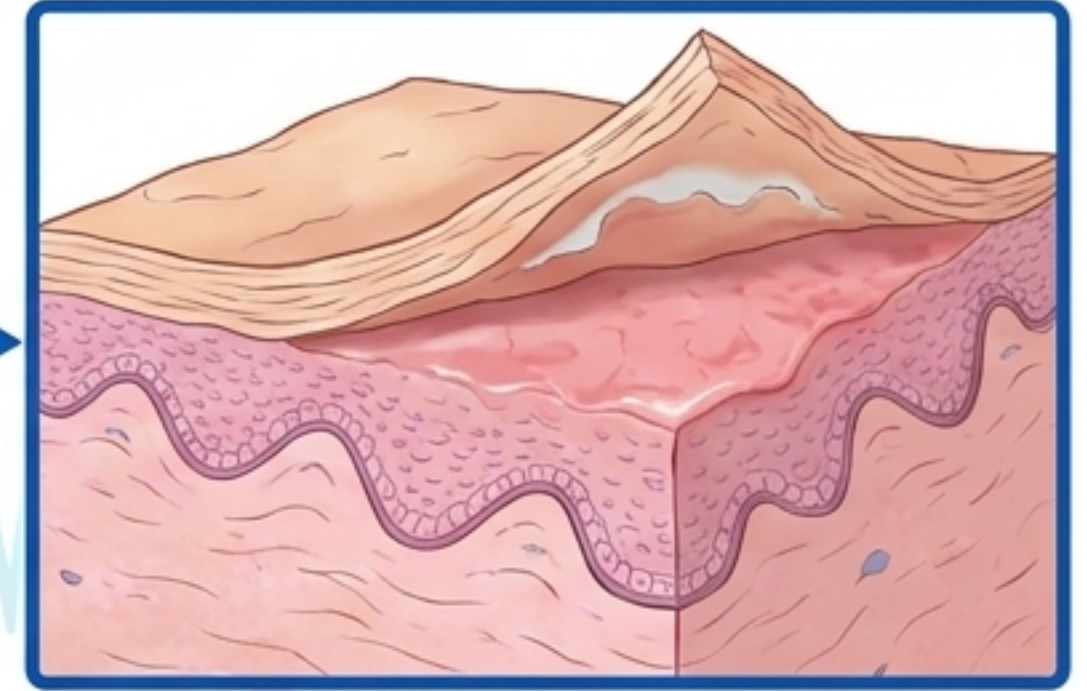
El Arsenal Diagnóstico Clínico: Signo de Nikolsky



Paso 1: Fricción firme sobre piel perilesional.



Paso 2: Separación mecánica por debilidad de uniones (Acantólisis).



Paso 3: Desprendimiento epidérmico visible.

POSITIVO (+)

Indica ruptura intraepidérmica: Pénfigos (Vulgar/Foliáceo), NET, Síndrome de Ritter.

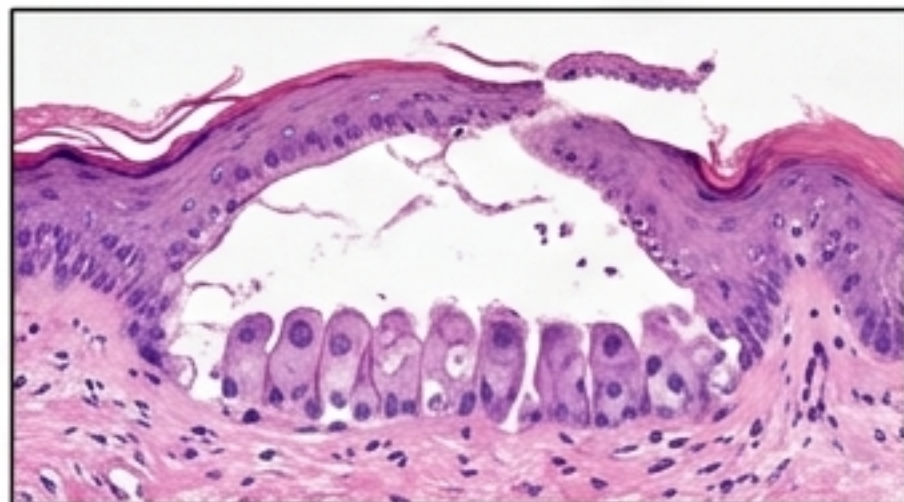
NEGATIVO (-)

Indica ampolla subepidérmica tensa: Penfigoides.

Nota: El Test de Tzanck permite diferenciar rápidamente lesiones virales (células gigantes) de las autoinmunes.

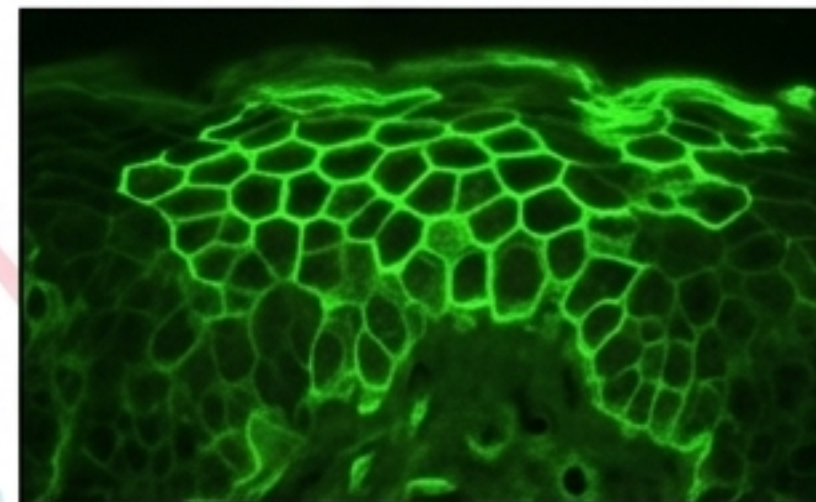
Confirmación Diagnóstica: Histopatología e IFD

Pénfigo Vulgar



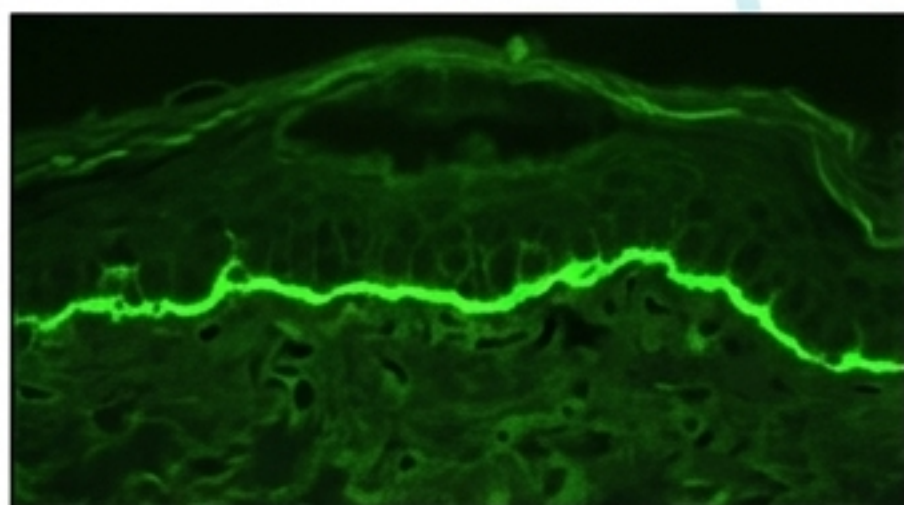
Histo: Acantólisis suprabasal ('Fila de lápidas').
IFD: Depósito de IgG intercelular (Patrón en red).

Pénfigo Foliáceo



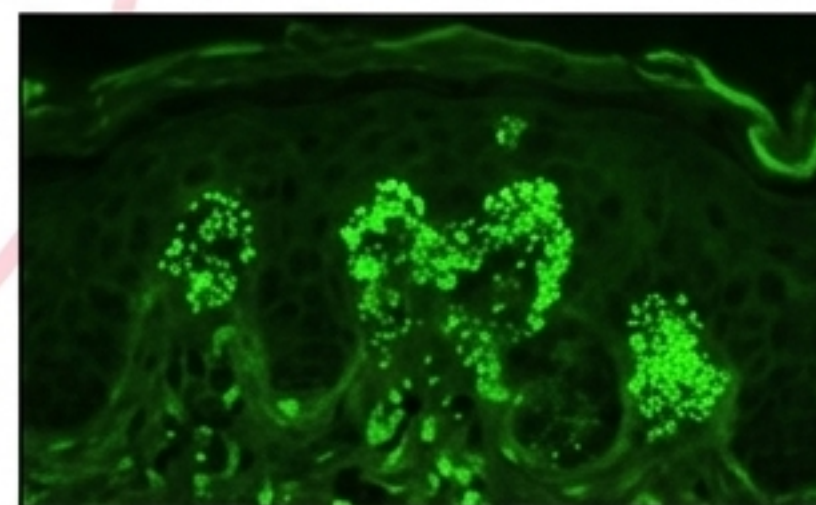
Histo: Acantólisis subcórnea superficial.
IFD: Patrón intercelular alto ('Panal de abejas').

Penfigoide Ampollar



Histo: Ampolla subepidérmica intacta.
IFD: Depósito LINEAL de IgG/C3.

Dermatitis Herpetiforme



Histo: Microabscesos en papilas.
IFD: Depósitos granulares de IgA.

Escalera Terapéutica Clásica

ESCALÓN 1: Soporte y Tratamiento Tópico

Solución astringente de Burow, corticoides tópicos. Manejo de barrera, temperatura y líquidos (Unidad de Quemados / UCI para casos severos).

ESCALÓN 2: Primera Línea Histórica (Sistémica)

Corticosteroides. Prednisona oral (altas dosis, ej. 2mg/kg) o Dexametasona en pulsos endovenosos.

Alerta clínica: Riesgo inminente de Síndrome de Cushing, diabetes inducida y necrosis avascular de fémur.

ESCALÓN 3: Inmunomoduladores (Ahorradores)

Azatioprina, Ciclofosfamida, Micofenolato Mofetilo.

Objetivo primario: inducir remisión a largo plazo y disminuir drásticamente la dosis de corticoides.

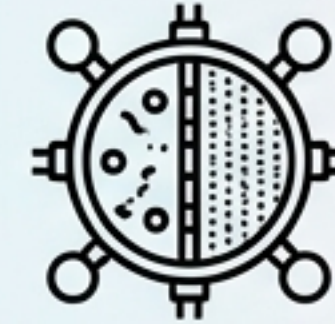
BADBEAR.MED

Arsenal Avanzado y Terapias de Rescate



Rituximab (El 'Misil' Biológico)

- **Anticuerpo** monoclonal Anti-CD20.
- **Mecanismo:** Elimina de forma selectiva los Linfocitos B productores de autoanticuerpos.
- **Advertencia Crítica:** Exige descarte estricto de infecciones crónicas o latentes (ej. Tuberculosis) previo a su uso.



Plasmaféresis

- **Mecanismo:** Filtración mecánica directa de autoanticuerpos circulantes en plasma.
- **Utilidad:** Efecto de rescate rápido pero transitorio (terapia puente).
- Requiere inmunosupresión sistémica conjunta para evitar el efecto rebote.